

2026-01-21

Dokumentnamn
Ställningstagande Läkemedel

Beslutsfattare/Ägare
Styrelsen

Beslutsdatum
2025-12-19

Verksamhetsområde
Vård och omsorg

Dokumentansvarig
Susanna Eklund

Ansvarig sektion/avdelning
Sektionen för hälso- och sjukvård

Dokumenttyp
Ställningstagande

Dokumentnummer
SKR2025/02981-3

Ställningstagande Läkemedel

SKR:s ställningstagande

En aktiv bevakning av medlemmarnas intressen är en av grunderna i SKR:s ändamål. SKR:s ställningstaganden tydliggör vår ståndpunkt i en viss avgränsad fråga och utgör underlag för påverkansarbetet och debatt. Ställningstaganden arbetas fram tillsammans med medlemsföreträdare på regional och lokal nivå och beslutas av SKR:s styrelse.

Bakgrund

Läkemedel utgör en del av hälso- och sjukvården och användningen ska precis som hälso- och sjukvården i övrigt vara jämlik, tillgänglig och effektiv. Säkerställd och rationell tillgång till kostnadseffektiva läkemedel utgör därmed en viktig förutsättning för patienter, hälso- och sjukvård och samhälle. För att samhällets och hälso- och sjukvårdens utmaningar ska kunna hanteras krävs effektivisering och ständiga förbättringar. Avgörande för ett sådant arbete är att nationella system och regler ger tydliga och långsiktiga förutsättningar till planering och utvecklingsarbete.

Dessa förutsättningar är inte tillräckliga med nuvarande system. Tvärtom försvårar och begränsar nuvarande nationella system och regler på flera sätt en entydig och rationell hantering av läkemedel med patientens behov i centrum.

Detta ställningstagande syftar till att beskriva Sveriges Kommuner och Regioners syn på några av de viktigaste utmaningarna på läkemedelsområdet och vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med dessa.

Ställningstagande

SKR anser att det behövs bättre förutsättningar för att nationella system och regler inom läkemedelsområdet ska kunna bidra till en entydig och rationell hantering av läkemedel med patientens behov i centrum. I detta ställningstagande beskrivs vilka åtgärder SKR anser behövas för att komma till rätta med de viktigaste utmaningarna för att våra medlemmar ska ges tydliga och långsiktiga förutsättningar till planering och utvecklingsarbete inom läkemedelsområdet.

1. Reglering utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i fokus behöver utvecklas

- Reglerna för läkemedelsförsörjning behöver utgå ifrån ändamålsenlighet, organisatoriskt vårdperspektiv och patientperspektiv.
 - Utredningen om säkrare tillgång till läkemedel är ett viktigt steg för att möjliggöra en framtida lösning som kan stärka förutsättningarna för regionerna att utveckla en läkemedelsförsörjning för all vård som regionerna ansvarar för i enlighet med de nya lagerhållningskrav som kommer att ställas på regionerna.
- En sammanhängande översyn av regelverk kring ordination, förskrivning och dokumentation i syfte att skapa en begriplig, överskådlig, långsiktig och sammanhållen reglering behövs.
 - Regelverken är komplexa och utgår från organisation snarare än från patienten. Olika delar av regelverket hanteras av olika myndigheter med olika men delvis överlappande uppdrag. Förändringar sker fragmenterat och det är svårt att få överblick över konsekvenser i hela kedjan.
- Tillgång till korrekt och aktuell information om läkemedel och läkemedelsbehandling, både för enskilda patienter och för sjukvården, behöver säkerställas.
 - Detta bör bland annat ske genom en nationellt sammanhållen läkemedelslista. En läkemedelslista där ordinationen utgör grunden samt kompletteras med information om förskrivning och expediering, och där patientinformationen hanteras dynamiskt och föränderligt utifrån patientens hälsosituation och behandling över tid bör utvecklas.
 - En gemensam nationell styrgrupp med mandat att fatta strategiska beslut om utveckling, införande och förvaltning av en nationell sammanhållen läkemedelslista bör utses. Styrgruppens sammansättning bör inkludera berörda aktörer tex regioner/huvudmän, kommun, apoteksaktörer, myndigheter, patient- och professionsföreträdare.

2. Systemen för finansiering och kostnadsansvar behöver förtydligas och förenklas

- Läkemedel är en insatsfaktor i sjukvården som behöver värderas och hanteras som en integrerad del av övrig vård och behandling.
- Läkemedel kan inte hanteras i ett helt eget spår vid sidan om övriga prioriteringar. Flera förändringar gällande hur läkemedel finansieras och hur kostnadsansvaret fördelas är angelägna.

Det gäller till exempel:

- En ny modell för solidarisk finansiering som fungerar för alla läkemedel och behovet av statlig medfinansiering för vissa rekvisitionsläkemedel.
- Långsiktiga planeringsförutsättningar och tydliga incitament för att påverka kostnader för läkemedelsanvändningen.
- Översyn av den värdebaserade prissättningen och förbättrade möjligheter till stärkt konkurrens.
- Säkrad finansiering över tid, oavsett recept/förmånsläkemedel eller rekvisitionsläkemedel.
- Förbättrade möjligheter för regionerna att styra och begränsa användningen av läkemedel inom läkemedelsförmånerna till de patienter som har störst behov.
- Förbättrade förutsättningar för gemensam nationell hantering och finansiering av vacciner till exempel möjligheter till fler kostnadseffektiva vacciner i nationella vaccinationsprogram.

3. Tillgängligheten till läkemedel måste säkras

- Det behövs fortsatta åtgärder i hela försörjningskedjan, från forskning och utveckling, tillverkning, lagerhållning och distribution till användning, för att stärka tillgången till läkemedel.
- Utökad omsättningslagring av läkemedel enligt målsättningarna i de överenskommelser som tecknats mellan SKR och regeringen omfattar läkemedel som används på sjukhus. Det behövs även åtgärder som säkerställer tillgång till läkemedel för öppenvården på motsvarande sätt, till exempel enligt förslagen från TLV som föreslår lagerhållningskrav för läkemedelsföretag (MAH).
- Utredningen *Säkrare tillgång till läkemedel* har i uppdrag att utreda många viktiga frågeställningar som kan bidra till att förbättra tillgängligheten till läkemedel.
 - Utöver lagerhållning behöver hela försörjningskedjan bidra med insatser för en mer robust läkemedelsförsörjning. Utredningen ska

bland annat föreslå vilka krav som bör gälla för öppenvårdsapotekens, och partihandlarnas beredskap.

- Idag saknas en tydlig strategi för hur tillgången till dosdispenserade läkemedel ska säkerställas och dospatienter undantas i Socialstyrelsens rekommendation om egenberedskap. Utredningen har i uppdrag att kartlägga dosverksamheten och föreslå ändringar som syftar till att förtydliga ansvar, finansiering och funktion.
- Förslagen från utredningen behöver omhändertas och beredas vidare för beslut och implementering.
- De senaste åren har det skett en positiv utveckling i den nationella samverkan både för att hantera kritiska bristsituationer och för samordning av försörjningsberedskapen för läkemedel.
 - Samarbetsformerna behöver fortsätta utvecklas och formaliseras för att tydliggöra ansvar och roller.
 - Det behövs också fler verktyg för att hantera de kritiska bristsituationer som kan uppstå både i vardag och kris. De förslag som lämnats för att möjliggöra frivillig fördelning och omfördelning, samt möjlighet att begränsa förordnande och utlämnande är positiva exempel som behöver tas vidare för beslut och implementering.
- Förutsättningarna för användning av läkemedel efter klinisk prövning men innan godkännande och subvention eller rekommendation är idag otydliga och inte enhetliga. Processer som kan bidra till en ordnad och jämlik tillgång till sådana läkemedel är angelägna att utveckla i samverkan mellan berörda myndigheter, läkemedelsföretagen och regionerna.

4. Förutsättningarna för uppföljning av läkemedelsanvändningen behöver stärkas

- Arbete nationellt behöver ha lika stort eller större fokus på uppföljning och utvärdering som på insättning och introduktion. Åtgärder för att minska onödig användning av läkemedel är lika angelägna som att kunna introducera nya kostnadseffektiva behandlingsalternativ.
- Tillgången på läkemedelsstatistik med hög detaljeringsgrad behöver säkerställas för regionerna men även för allmänhet, patienter, media och företag. Den nationella ambitionen ska tydligt vara att vidareutveckla den uppföljning som en sammanhållen läkemedelsstatistik möjliggör.
- Staten behöver ta ett mer tydligt samordnande ansvar för att utveckla de nationella myndigheternas arbete kring uppföljning av all läkemedelsanvändning avseende effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet och stärka och tydliggöra sitt förhållningssätt kring prioriteringar.
- Lagstiftning behöver anpassas så att regionernas möjligheter till rationell och effektiv uppföljning underlättas.

- Regionernas möjligheter att förebygga, upptäcka och åtgärda oegentlig förskrivning och välfärdsbrottslighet måste förbättras.

5. Samlat agerande för att möta förändrad EU-reglering och internationell utveckling och osäkerhet behövs

- Staten har och behöver ta ett övergripande ansvar för omvärldsförändringar som påverkar den svenska läkemedelsmarknaden – ett påtagligt sådant exempel är utvecklingen rörande prissättning i omvärlden.
- Etableringen av Swetrial och andra åtgärder för att stärka Sverige som attraktivt för kliniska prövningar är angelägna.
- Svenska och nordiska intressen är viktiga att kraftfullt föra fram i pågående översyn av EU lagstiftningen, etableringen av Critical Medicinal Alliance och uppdrag för HERA.
- Stärkt nordisk samverkan kan både påverka och underlätta pågående förändringar och på ett bättre samlat sätt möta upp mot krav och önskemål som förs fram av andra aktörer som t.ex. läkemedelsindustrin.